NEURO · NE-02

Sclérose en plaques · McDonald 2024

McDonald 2024 (Lancet Neurol 2025)
dissémination spatiale et temporelle, veine centrale, lésions à bord paramagnétique

LES 5 RÉGIONS DE DISSÉMINATION SPATIALE (DIS)

Périventriculaire
au contact du ventricule, sans substance blanche interposée

Cortical / juxtacortical
dans le cortex ou au contact

Sous-tentoriel
tronc cérébral, pédoncules, cervelet

Moelle
cervicale et thoracique

Nerf optique
nouveau
IRM, OCT ou PEV

DIS : au moins 1 lésion T2 dans au moins **2 des 5 régions**. **DIT** (dissémination temporelle) : nouvelle lésion T2 au contrôle, ou au moins 1 lésion rehaussée par le gadolinium, ou nouvelle poussée clinique.

ALGORITHME SIMPLIFIÉ · PRÉSENTATION TYPIQUE

SITUATION	CE QU'IL FAUT EN PLUS
DIS ≥ 4 régions	**Diagnostic de SEP**, sans DIT, si le syndrome est typique et les diagnostics différentiels exclus
DIS 2–3 régions	Une preuve supplémentaire : **DIT**, ou **LCR positif** (bandes oligoclonales ou kFLC), ou biomarqueur IRM (**veine centrale** ou **lésion à bord paramagnétique**) selon l'algorithme
Forme progressive	Progression ≥ 12 mois ; **≥ 2 lésions médullaires** suffisent pour la DIS, même sans lésion cérébrale
Asymptomatique (ex-RIS)	Lésions typiques dans ≥ 2 régions + **≥ 6 lésions à veine centrale**, ou LCR positif, ou DIT. Une seule région : jamais suffisant

NOUVEAUX BIOMARQUEURS IRM

Signe de la veine centrale (CVS)

- Petite veine au centre d'une lésion de la substance blanche, en T2* ou SWI (3 T idéal mais non obligatoire)
- **Positif** si **≥ 6 lésions** à veine centrale ; si < 6 lésions au total, il en faut plus de la moitié
- Les lésions microvasculaires n'ont pas de veine centrale

Lésion à bord paramagnétique (PRL)

- Liseré hypo-intense en imagerie de susceptibilité autour d'une lésion
- **Positif** si **≥ 1 PRL** ; très spécifique, peu sensible
- Preuves insuffisantes pour l'utiliser en situation asymptomatique

NERF OPTIQUE · COMMENT LE DÉMONTRER

IRM
Hypersignal T2 / STIR du nerf optique, rehaussement en aigu

OCT
Asymétrie inter-œil : RNFL péripapillaire ≥ 6 µm ou GCIPL maculaire ≥ 4 µm

PEV
Allongement de la latence P100 ou asymétrie > 2,5 DS

PIÈGES ET POPULATIONS PARTICULIÈRES

Plus de 50 ans · facteurs vasculaires
prudence, les lésions microvasculaires imitent la SEP ; s'appuyer sur la veine centrale, la moelle, le LCR

Névrite optique
exclure NMOSD, MOGAD, neuropathie ischémique : aussi fréquents que la SEP

Enfant
mêmes critères ; rechercher les anticorps anti-MOG avant 12 ans

Protocole
FLAIR 3D, T2, T1 gadolinium, moelle sagittale, ± T2*/SWI pour la veine centrale

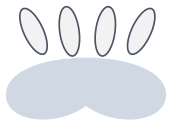
Sclérose en plaques · McDonald 2024

(suite)

McDonald 2024 (Lancet Neurol 2025)
dissémination spatiale et temporelle, veine centrale, lésions à bord paramagnétique

ATLAS VISUEL

Topographie des lésions et biomarqueurs



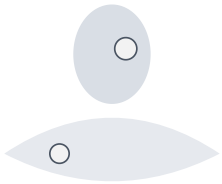
contact ventriculaire

Périventriculaire
ovoïdes ⊥ ventricules



au contact du cortex
ou dans le cortex

Cortical / juxtacortical



tronc · cervelet

Sous-tentoriel



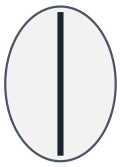
≤ 2 étages

Moelle
lésion courte, périphérique



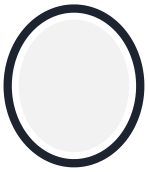
T2/STIR, OCT, PEV

Nerf optique
nouvelle 5ᵉ région



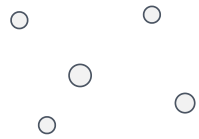
T2* / SWI

Veine centrale
≥ 6 lésions positives



liseré hypo-intense

Bord paramagnétique
≥ 1 PRL



ponctuées, sous-corticales

Microvasculaire
pas de veine centrale

Schémas simplifiés, non à l'échelle

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

Signe de la veine centrale
Radiopaedia · technique et seuils
radiopaedia.org/articles/central-vein-sign-1

Doigts de Dawson (cas)
Radiopaedia · lésions périventriculaires
radiopaedia.org/cases/multiple-sclerosis-dawson-

Lésions à bord paramagnétique
Radiopaedia · imagerie de susceptibilité
radiopaedia.org/articles/paramagnetic-rim-lesion

Critères de McDonald
Radiopaedia · versions successives
radiopaedia.org/articles/mcdonald-diagnostic-cri

Consensus IRM MAGNIMS
Radiopaedia · protocole IRM
radiopaedia.org/articles/magnims-consensus-on-mr

Syndrome radiologiquement isolé
Radiopaedia · forme asymptomatique
radiopaedia.org/articles/radiologically-isolated

Sources : ECTRIMS – 2024 Revisions to McDonald criteria – ectrims.eu/press/revisions-to-mcdonald-diagnostic-criteria-f... · Practical Neurology – 2024 McDonald criteria – pn.bmj.com/content/26/5/440 · Application des critères 2024 (RIS) – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13267864/